Órganos de Gestión.

En el punto 4. del Manual se desarrollan de forma específica y detallada, por su importancia en la metodología, las herramientas u órganos de gestión del Programa de Cuidados Crónicos Avanzados Newcare.

4.1. ASAMBLEA DE PACIENTES.

Es el órgano representativo de los de pacientes y familiares/cuidadores con atención en el programa de cuidados crónicos avanzados Newcare; en esta participan tanto pacientes como organizaciones de pacientes de las diferentes enfermedades descritas en el programa.

En esta Asamblea, se tomarán decisiones relativas a la calidad asistencial de los pacientes. Será la forma más democrática y efectiva de tratar ciertos temas y tomar decisiones al respecto que no deben ser resueltas por una única persona. Su finalidad es debatir sobre aspectos fundamentales que influyen en la calidad de la atención y en la percepción de dicha calidad por los pacientes y familiares, sobre la base de un consenso.

La Asamblea de pacientes es convocada y liderada por la aseguradora. En la Asamblea se levantará acta de esta con los compromisos acordados y responsables de los mismos, para ser evaluados en la siguiente reunión.

- **Funciones de la Asamblea de Pacientes.**

El objetivo final es revisar el programa de cuidados avanzados para comprobar si el modelo implantado cumple con las necesidades de los pacientes, así como debatir cuestiones que surjan una vez que el programa ya esté llevando a cabo con los pacientes.

La lista de contenidos y temas a trabajar en las Asambleas será dinámica y por tanto estará sujeta a modificaciones en base a propuestas, acontecimientos, evaluaciones, etc.

Se ofrecerá la oportunidad de que los participantes libremente propongan aspectos sobre los que creen importantes debatir siempre que estos vayan relacionados con los dos objetivos principales de la metodología que hacen referencia a los pacientes y familiares: mejora en salud y mejora en la experiencia del cuidado de la persona y la familia.

Cualquier tema que se quiera debatir deberá ser comunicado con 10 a 15 días de antelación a la aseguradora para que este tenga el tiempo de incorporarlo al orden del día de la convocatoria que deba realizarse y se planifique si se debate en sesión ordinaria y/o en sesión extraordinaria.

Los aspectos a revisar serán los siguienres:

- Calidad de la atención,
- Necesidades que con un criterio subjetivo por parte de los pacientes y sus familias no se están cumpliendo hasta el momento tal y como se venían trabajando.
- Adecuación de las instalaciones.
- Cuestiones relativas a las consultas, las pruebas y los tiempos de espera.
- Trato y la actitud de personal que les atiende.
- Calidad y eficacia de la comunicación con los profesionales sanitarios (tanto de los profesionales hacia los pacientes y familiares), si es una comunicación efectiva, adecuada, continua, colaborativa (con consenso con el paciente para cuestiones como el plan de atención individualizado) etc., tanto de los pacientes con los profesionales: si tienen un fácil acceso a ellos, si encuentran respuestas ágiles a sus preguntas y preocupaciones, si se les dedica el tiempo que necesitan para resolver su necesidad.

- Cobertura de las necesidades específicas de una persona con IOCC.

- **Participantes de la Asamblea de Pacientes.**
  - Un representante del Asegurador.
  - Trabajador social de cada prestador o aquel perfil que cumpla con el conocimiento y la cercanía a la realidad de las necesidades de los pacientes y familiares desde un enfoque bio-psico-social.
  - Médico general o internista de los prestadores.
  - Al menos una persona que pueda participar en representación de los pacientes por experiencia propia.
  - Una persona que pueda participar en representación de los familiares de los pacientes por experiencia propia.
  - Un profesional de alguna entidad social, que pueda ofrecer información general de las necesidades de los pacientes con IOCC y que sea preferiblemente externo a la aseguradora.
  - Representantes de entidades/asociaciones de pacientes
  - Representantes de agentes clave del Programa de cuidados avanzados Newcare. (Los agentes Clave son entidades con los que la Aseguradora ha realizado acuerdos de colaboración para favorecer de recursos o acciones al Programa.)

- **Responsable:**
  - La Asamblea de pacientes es convocada y liderada por la aseguradora, quien levantará acta con los compromisos acordados y responsables de los mismos, para ser evaluados en la siguiente reunión.

- **Periodicidad**: mínimo anual. La primera debe hacerse a los 6 meses de arrancar el Programa.

4.2. JUNTA DE CRONICIDAD CLÍNICA.

La Junta de cronicidad clínica es una estructura de coordinación entre la aseguradora y el Prestador. Cada regional de la aseguradora formará una Junta de cronicidad clínica de ámbito asistencial, que será la responsable de velar por el continuum asistencial del paciente y su familia. En estas reuniones se sacarán conclusiones sobre si el proceso de atención al paciente está siendo el adecuado, etc., y se determinará si cada paciente sigue o no con el plan pautado según su evolución y otros condicionantes que se consideren para ello.

- **Funciones de la Junta de Cronicidad Clínica.**
  - Seguimiento de los pacientes en programa, cuantos pacientes tengo en programa, quien tiene a cada paciente a su cargo, como están evolucionando, problemas detectados a nivel tanto clínico como psicosocial, etc.
  - Ratificación de valoraciones y la determinación final del nivel de complejidad tras la valoración multidimensional.
  - Consensuar qué nuevos pacientes son mensualmente candidatos a la valoración multidimensional, así como su asignación al prestador correspondiente cuando cumplen criterio de inclusión al programa.
  - Exponer la situación actual y evolución de cada paciente por parte del equipo tratante y acordar un plan de atención individualizado para cada uno. Realizando propuestas y reajustes si fueran necesarios.

- Analizar la necesidad de cambios de ámbito de atención y niveles asistenciales, gestionando las transiciones con vistas a que exista una verdadera atención integrada.

- Revisar si los pacientes de atención domiciliaria están teniendo muchas visitas a urgencias o ingresos en el hospital. Detectar cuales son las causas e intensificar los aspectos que están fallando en la atención domiciliaria.

- Valorar la atención y los procesos que está siguiendo cada paciente, interacción con paciente y familia.

- Comentar los pacientes nuevos que se han identificado cada mes para realizar la valoración multidimensional y asignación de los mismos a los prestadores que operan el programa.

- Revisar el tratamiento que ha sido pautado y siguen los diferentes pacientes para conocimiento de los diferentes niveles y prestadores que puedan estar implicados en su atención.

- En ellas se puede hablar también sobre resolución de conflictos entre profesionales en caso de su existencia, de tal forma que los equipos funcionen bien.

- Comentar los problemas de atención social y/o sanitaria que surjan en cada paciente en cada momento y proponer soluciones.

- Conocer los recursos y servicios socio-sanitarios disponibles y proponer aspectos a mejorar en la atención directa.

- Decidir transición a Programa de Cuidados Paliativos de los casos que se consideren

- **Participantes de la Junta de Cronicidad Clínica.**

Las Juntas de cronicidad clínica que trabajarán los aspectos asistenciales de los pacientes, estarán compuestas por las siguientes personas:

- Care Manager o gestor de cuidados de la aseguradora

- Un representante de cada uno de los equipos tratantes responsable de la valoración multidimensional y plan de atención del paciente (médico Líder o médico tratante).

- Trabajadora social del equipos de crónicos.

- Referente Clínico (preferiblemente el Médico Internista o especialista Hospitalario que el asegurador delega en su Red)

Además de estos profesionales, podrán acudir:

- El Líder Nacional de Programa por parte de la Aseguradora.

- Cualquier profesional susceptible de aportar información relevante de los pacientes tales como enfermeras jefe, psicólogos de los equipos tratantes, trabajadores sociales de los equipos, etc.

- **Responsable:** Las reuniones de la Junta de cronicidad clínica, las lidera el Asegurador quien levantará acta de cada reunión, con los compromisos acordados y responsables de los mismos, para ser evaluados en la siguiente reunión.

  - **Periodicidad**: La periodicidad de la junta será Mensual. Se inician posterior el ingreso de pacientes.

4.3. JUNTA DE CRONICIDAD ADMINISTRATIVA.

La Junta de Cronicidad Administrativa es una estructura de coordinación entre la Aseguradora y el Prestador, así como de los prestadores entre sí para el seguimiento de la gestión administrativa del Programa. Cada regional de la Aseguradora a través de su Case Manager estará representada en esta junta, que trabajará aspectos relacionados con la gestión del programa de Cuidados avanzados.

La Junta de Cronicidad administrativa será dirigida por el Case manager del programa de cuidados avanzados de asegurador, quien será el responsable de ir evaluando los resultados según los indicadores previstos y tendrá una duración que permita abordar todos los aspectos necesarios.

- **Funciones de la Junta de Cronicidad Administrativa.**

En las reuniones de gestión se revisará el funcionamiento administrativo del programa, se analizará el comportamiento de la red de prestadores que integra el programa en función de los datos de control, abordando temas tales como:

  - Analizar los indicadores que están relacionados con la gestión, en relación con la cobertura, etc., y se irán definiendo los ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos.
  - Unificar criterios y marcar objetivos y/ directrices más o menos comunes (teniendo en cuenta las particularidades de cada regional).
  - Identificar e intervenir oportunamente las desviaciones administrativas que generen impacto en la salud de los pacientes.
  - Debatir sobre la información compilada por parte de los Case Manager en relación con la cobertura del programa, los gastos, el número de pacientes, etc.
  - Proponer y participar en la elaboración de protocolos que puedan mejorar el funcionamiento del programa.
  - Elaborar propuestas de coordinación entre regionales y prestadores, de los prestadores entre sí y entre territoriales de la Aseguradora
  - Conocer los recursos, así como los servicios sanitarios y sociales y los procedimientos asistenciales de su demarcación geográfica.
  - Debatir sobre los equipos tratantes, analizar su organización, y proponer modificaciones tanto en su número como en su composición si se considerase necesario.
  - Supervisar a los prestadores, realizando seguimiento de su actividad y ofrecerles apoyo y asesoramiento en caso necesario.
  - Las Aseguradora compartirán con los prestadores el análisis del programa con aspectos también positivos del mismo.

- **Participantes de la Junta de Cronicidad Administrativa.**

La Junta de cronicidad que trabajará aspectos relacionados con la gestión del programa, estarán compuestas por las siguientes personas:

  - Los Case Managers de cada regional de la Aseguradora en al que se haya implantado el programa.
  - Un representante (de cada prestador) del ámbito administrativo que controle la gestión administrativa
  - Líder Nacional y Directores regionales de Salud del Asegurador

- Cualquier profesional susceptible de aportar información relevante en la gestión del programa.

- **Responsable:** Las reuniones de la Junta de cronicidad clínica, las lidera el Asegurador quien levantará acta de cada reunión, con los compromisos acordados y responsables de los mismos, para ser evaluados en la siguiente reunión.

- **Periodicidad**: Trimestral.

4.4. Gestión interna del equipo. Reuniones.

Es este apartado es importante describir las reuniones clínicas de valoración y de toma de decisiones en las que están involucrados los miembros del equipo, tales como:

- Reuniones de equipo por niveles
- Reuniones de equipo generales
- Reuniones con paliativistas para derivación a paliativos
- Reuniones de formación/sesiones clínicas
- Reuniones de Líder y Case para gestión de recurso
- Reuniones del líder con médicos especialistas referentes para consenso de criterios o apoyo de toma de decisiones
- Asamblea de pacientes
- Comisión sociosanitaria
- Juntas de Cronicidad

Es indispensable añadir, además un cuadro resumen de reuniones que detalle la siguiente información: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Se anexan ejemplos:

Tabla

Reunión	Asistentes	Responsabl	Periodicida	Fecha y hor	Lugar	Producto
Asamblea de pacienes	* Representante de la Aseguradora: líder de la Asamblea de Pacientes * Trabajador social de cada prestador o aquel perfil que cumpla con el conocimiento y la cercanía a la realidad de las necesidades de los pacientes y familiares desde un enfoque bio-psico-social. * Médico general o internista de los prestadores * Representante de los pacientes. * Representante de la familia. * Un profesional de alguna entidad social, externo a la aseguradora. * Representantes de entidades/asociaciones de pacientes. * Representantes de agentes clave del Programa.	Aseguradora	Anual (Primera a los 6 meses)	Martes 4 pm	Auditorio EPS	Acta con compromisos
Junta de cronicidad clínica	Obligatorios: * Case Manager o gestor de cuidados de la aseguradora * Un representante de cada uno de los equipos tratantes responsable de la valoración multidimensional y plan de acción del paciente (médico Líder o médico tratante). * Trabajadora social de los equipos domiciliarios crónicos. * Referente Clínico (preferiblemente el Médico Internista o especialista Hospitalario que el asegurador delega en su Red) Opcionales: * El Líder Nacional de Programa por parte de la Aseguradora. * Cualquier profesional susceptible de aportar información relevante de los pacientes	Aseguradora	Mensual	Primer lunes del mes 7 am	Virtual	Acta con compromisos
Junta de cronicidad Administrativa	* Los Case Managers de cada regional de la Aseguradora en al que se haya implantado el programa. * Un representante (de cada prestador) del ámbito administrativo que controle la gestión administrativa * Lider Nacional y Directores regionales de Salud del Asegurador * Cualquier profesional susceptible de aportar información relevante en la gestión del programa.	Aseguradora	Trimestral	Cuarto jueves de cada mes 9 am	Virtual	Acta con compromisos
Otras Juntas	Equipo Asistencial Médico general Médico internista Enfermería Trabajo social	Líder del equipo	Semanal	Viernes 8 am	Sala de juntas	Acta con compromisos

Planeador

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
7 a 8	Junta de cronicidad clínica Primer lunes del mes (Mensual) 7 a 9 am				
8 a 9					Reuniones de equipo Semanal de 8 a 9 am
9 a 10				Junta de cronicidad administrativa Cuarto jueves Trimestral 9-11 am	
10 a 11					
11 a 12					
12 a 13					
13 a 14			Reuniones de gerencia Segundo miércoles de cada mes. Mensual 13-16		
14 a 15					
15 a 16					
16 a 17		Asamblea de pacientes 4-6 pm (anual)			
17 a 18					

Documentos generados:

Tras cada Junta de Cronicidad (clínica o administrativa), reuniones o asambleas que se celebren (ordinaria o extraordinaria), se acompañará un acta, que remitirá la persona responsable de la reunión por escrito a todos los participantes.

Las actas contendrán como mínimo:

- Fecha y la hora de comienzo de la Asamblea.
- Los nombres y apellidos de los participantes.
- El lugar de celebración.
- Los temas tratados.
- Las conclusiones a las que se ha llegado.
- Los compromisos o propuestas de actuación: con la identificación de responsables y la fecha de ejecución máxima de dichos compromisos.
- Observaciones
- Avances o cierre de compromisos anteriores.